

Œil rouge

Anamnèse:

- Symptômes oculaires
 - o Chronologie:
 - Aigu?
 - Durée?
 - Récidive?
 - o **Uni vs bilatéral**
 - o **Douleur**
 - o **Prurit**
 - o **Corps étranger**
 - o **Vision**
 - **Acuité visuelle**
 - **Diplopie**
 - o **Photophobie**
 - o **Sécrétions**
- Symptômes généraux
 - o Notamment **uro-génitaux**
 - o Céphalée
 - o Éruption cutanée
 - o Arthralgie
- Antécédents :
 - o Ophtalmologiques (opération !)
 - o Trauma (physique, chimique, UV)
 - o Allergies
 - o Maladie chronique
 - o **Médicaments**
- Contexte :
 - o Contacts
 - o Environnement (famille, professionnel)
 - o **Verres de contact**

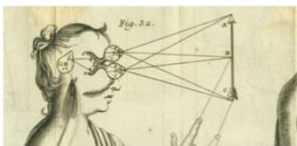
Examen clinique :

« Examen d'un œil rouge »: V-P-C-C-P

1. Vision-général:

Acuité visuelle, champ visuel

Aspect général ? Atteinte uni- ou bilatérale ? Tonus oculaire



2. Paupières

Ouverture, tuméfaction, inflammation, bord, région périoculaire, ganglion préauriculaire

unisanté
Centre universitaire de médecine générale
et santé publique - Louvain



3. Conjonctive :

localisation, type, intensité de la rougeur (ciliaire?); corps étranger, sécrétions (aqueuses, mucineuses, purulentes), papilles, follicules



4. Cornée :

transparence, ulcère, corps étranger, Hypopyon ? Hyphema ?



5. Pupilles :

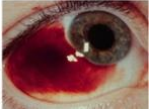
Isocores, réactives?



Drapeaux rouges → consultation ophtalmique :

- Baisse de l'acuité visuelle
- Diplopie
- Douleur aigüe
- Céphalées
- ATCD intervention chirurgicale
- Œil unique
- Traumatisme
- Zona ophtalmique
- Anisocorie nouvelle
- Exophtalmie nouvelle
- Cave: porteur lentille de contact
- **Symptômes uro-génitaux → chlamydia – gonorrhée**

DD :

- **Conjonctivite allergique** : 2 yeux rouges, prurit, larmoiement, conjonctive palpébrale folliculaire, atopie
- **Conjonctivite virale** : 2 yeux rouges (1 plus que l'autre parfois), larmoiement, sensation de CE, sécrétions séro-muqueuses, conjonctives palpébrales folliculaire, ganglion, IVRS en cours
- **Kératoconjonctivite épidémique (adénovirus)** : rougeur bilatérale, aigu, douleurs, sensation de CE, vue diminuée, sécrétion → ophtalmo pour surv. kératite
- **Conjonctivite herpétique (simplex – zoster)** : lésions cutanées, unilatéral, rougeur, douleur, *photophobie*, vue diminuée → ophtalmo pour surv. (kératite, uvéite)
- **Conjonctivite bactérienne** : unilatéral, gêne, sécrétion purulente, conjonctives hyperémiées, penser à chlamydia et gonocoque en absence d'amélioration ou lors d'apparition hyperaiguë → ophtalmo
- **Conjonctivite irritative** : lors de yeux secs (hiver, Sjögren), de traumatismes, de verres de contact, de maladie de Basedow ou de maladies systémiques
- **Hyposphagma – hémorragie sous-conjonctivale** : rougeur circonscrite, pas de gêne, pas de douleurs, vue ok, suite à un valsalva, traumatisme, HTA ou spontané → ophtalmo si récidive 
- **Uvéite antérieure** : rougeur, *injection périkeratite*, douleurs, *photophobie*, vision trouble, hypopion, pas de sécrétion, cause : idiopathie, infectieuse, auto-immune (associé à des arthralgies, fatigue), sarcoïdose, systémique (HLA B-27) → ophtalmo 
- **Épisclérite** : rougeur localisée – sectorielle, sclère visible entre les vaisseaux, respecte l'iris, sécrétions
- **Pterygion** : rougeur localisée – sectorielle, ne respecte pas l'iris
- **Blépharite** : croûte matinale, gêne, sécrétions, œdème palpébral, pas de douleurs, vue sp 
- **Chalazion** : œdème palpébral circonscrit, vue sp 
- **Orgelet** : abcès d'un follicule pilo-sébacé du cil
- **Ectropion**
- **Glaucome aigu** : HTA, douleurs +++, rougeur diffuse, *photophobie*, vision trouble, halo, pupille fixe, tonus oculaire augmenté → ophtalmo en urgence